

Περίπτωση 32η

Άνδρας 22 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με επιγαστραλγία και διάρροια από 24ώρου.

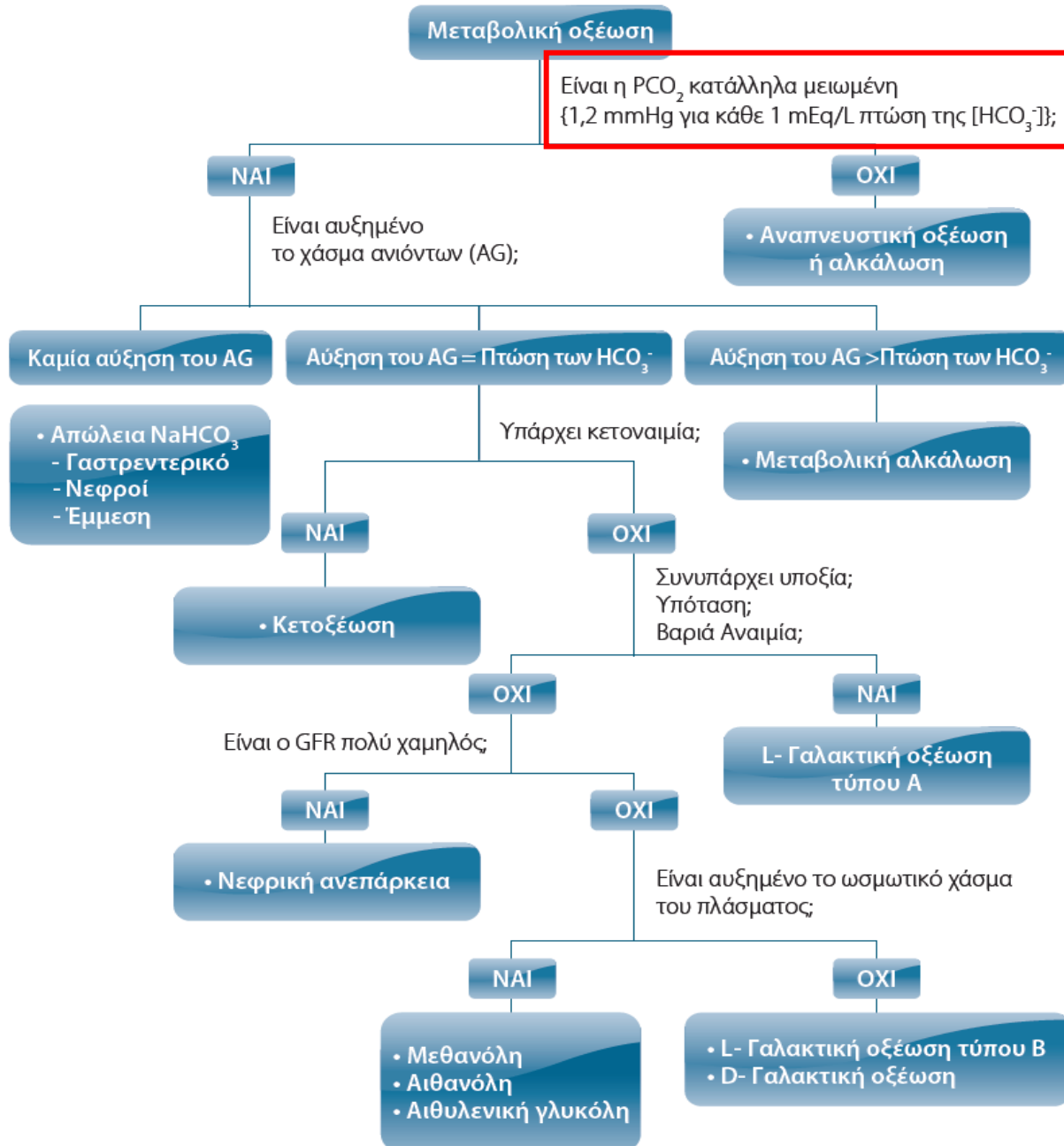
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 86 mmHg
- PCO₂ = 40 mmHg
- pH = 7.10
- [HCO₃⁻] = 12 mEq/L
- [Na⁺] = 133 mEq/L
- [K⁺] = 2.8 mEq/L
- [Cl⁻] = 109 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 107 mg/dl
- [Ουρίας] = 52 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.1 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση

- pH = 7.10 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση (κύρια διαταραχή)**

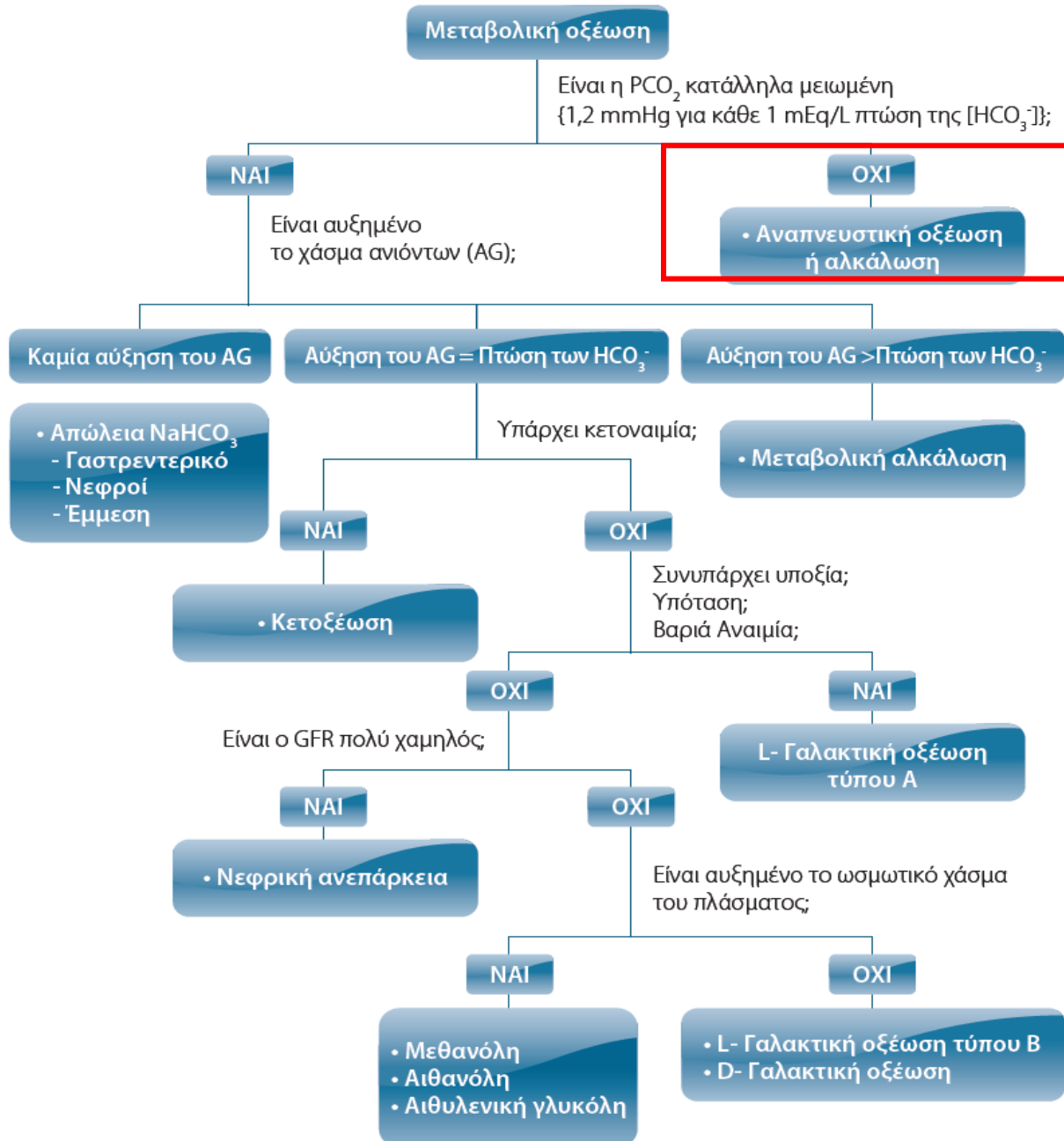
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 12 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 12 mEq/L
- Αναμενόμενη ↓ $\text{PCO}_2 = 12 \times 1.2 = 14.4 \text{ mmHg}$ ($\text{PCO}_2 = 25-26 \text{ mmHg}$)
- $\text{PCO}_2 = 40 \text{ mmHg}$
- **Συνυπάρχει αναπνευστική οξέωση**

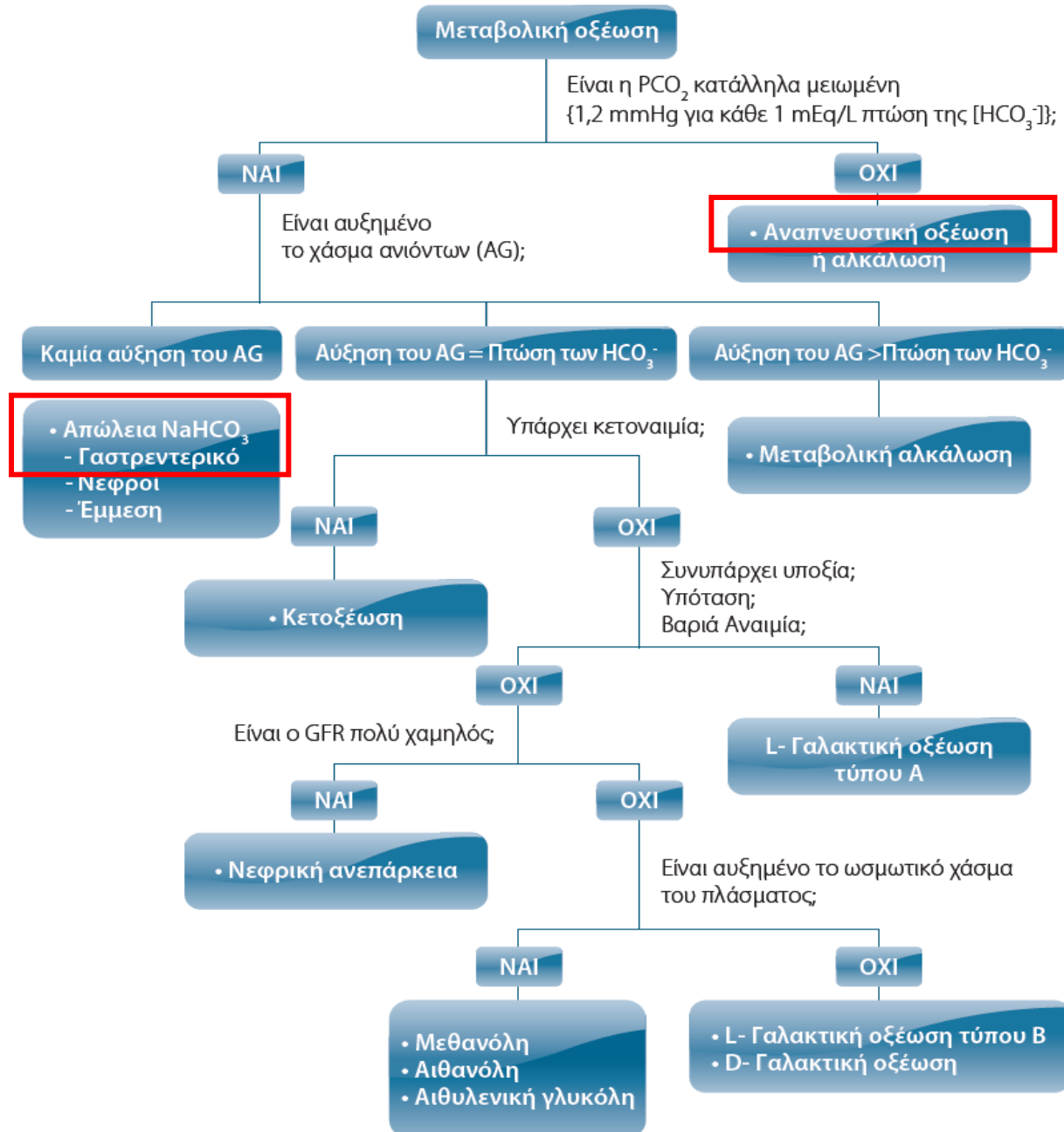
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 133 - (109+12) = 12 \text{ mEq/L}$
- $AG = \text{φυσιολογικό}$
- **Μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό AG** που οφείλεται σε απώλεια HCO_3^- από το γαστρεντερικό σωλήνα λόγω διαρροιών

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



(A-a) DO₂

- (A-a) DO₂ = [150 – 1.25 X (PCO₂)] - PaO₂ = [150 – (1.25 X 40)] – 86 = 150 – 50 – 86 = 14 mmHg
- Φυσιολογική (A-a) DO₂ = νευρολογική ή μυϊκή πάθηση

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό χάσμα ανιόντων λόγω άμεσης απώλειας HCO_3^- από το γαστρεντερικό σωλήνα συνεπεία διαρροιών και αναπνευστική οξέωση λόγω μυϊκής αδυναμίας και υποαερισμού συνεπεία υποκαλιαιμίας και διαρροιών

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Χρόνια αναπνευστική οξέωση
- β. Οξεία αναπνευστική οξέωση
- γ. Μεταβολική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση